جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : فوقية سيد بدر رزق
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** مصر القديمه **العنوان :** =
رقم البطاقة : 26501121301641 **رقم التليفون :** 01030565982 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 18-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 12-01-1965 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي الصدر والبطن والحوض بالصبغه [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: فوقية سيد بدر رزق
National ID: 26501121301641

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Contrast-enhanced CT of chest, abdomen, and pelvis**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

ame	: الاسكندرية / توفيقيه سيد بدر	Request No.	: 13005437
o.	: 26501121301641	Request Date	: 18/05/2023
	: 1499/23	Verification Date	: 29/05/2023
	: Female	Financial Category	: البرنامج دار السلام - فئة الدولة
	: 57 Y	Department	: Out Patient
g Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

)ata:
st cancer, post hormonal therapy.
pecimen:
e local excision and axillary clearence specimens 18/5/23.
amination :
ary clearence specimen: A fibrofatty tissue piece measured 8x3 cm entangling 10
up to 1x1 cm.
e local excision specimen measured 10x9x5.5 cm, with covering skin ellipse
d 6x2 cm
extent: A firm grayish white tumor bed site
3x2.5 cm
olvement:Unrammarkable grossly
e from margins: 0.3cm from inferior margin (least margin)
perior margin : Fibrofatty tissue peice measuring 3x1.5 cm , free of gross
ns .
erior margin : fibrofatty tissue peice measuring
, free of gross indurations
ection:
rgins with close superior and inferior margins
e margins
pic Examination :
ical Type: Invasive duct carcinoma .
tiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): II(3+2+1) Grade II .
tumor diameter: 4x3cm
mor cellularity: 95%, tumor necrosis index: 5%
arcinoma in situ: No .
olvement: Free .
ode involvement: Negative (0/10)

erified by :

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: فوقيه سيد بدر **MR. :** 5072	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient has a history of left-sided breast cancer, grade 8/8, progesterone receptor 6/8, HER2-negative, with initial mediastinal, abdominal, and pulmonary lymph node involvement. Hormonal therapy was initiated in 2020 and continued until left-sided disease progression in May 2023 (ypt2 ypn0). The patient was subsequently placed on an aromatase inhibitor (arimidex) starting in June 2023 for new disease assessment, including pulmonary nodules and mediastinal lymph nodes; a breast imaging report in September 2025 described the lesions as BIRADS 2 while on arimidex.

In April 2026, a computed tomography scan demonstrated total resolution of mediastinal lymphadenopathy. The patient continues on arimidex with supportive care for an additional three months.

تحريرا في ,

التاريخ :	20-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

me	: الاستاذه / نرجيه سيد بدر	Request No.	: 13005437
.	: 26501121301641	Request Date	: 18/05/2023
	: 1499/23	Verification Date	: 29/05/2023
	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - تكلفة الورقة
	: 57 Y	Department	: Out Patient
Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

vasion: No .
al invasion: No
on Margins: All margins are free .
ic response to therapy: Partial pathological respone .

:
t cancer post hormonal therapy, wide local excision and axillary clearence
s:
duct carcinoma , grade II .
rgins and extra margins.
ph nodes (0/10) .
gic partial respone
pT2 , ypN0
636, RCB class II .

Signature
Dr. Rana Fathy
Dr. Menan Hossam

anfied by :
r asraa magdy

Name : Fawkia Sayed Ali | Date : 21-9-2021

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED:

Compared to the previous study dated 23/3/2021 the current study shows:

1. *Chest:*

- Mild increase in size of the left axillary level I and II enlarged lymph nodes the largest measures 1.3 cm compared to 1 cm previously.
- Stationary left breast inner quadrant irregular speculated mass lesion measuring 4 x 2.3 cm.
- Rather stationary extensive bilateral scattered tiny pulmonary nodules, the largest measuring 8 mm.
- Rather stationary enlarged right para-tracheal and subcarinal mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. *Abdomen and pelvis:*

- The liver is enlarged with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Left adrenal hypodense lesion is still seen and still measures 1.4 X 0.7 cm (likely adenoma).
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and right supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The scanned skeleton shows dorso-lumbar spondylosis, no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.

OPINION:

Follow up study showing:

- *Mild increase in size regarding the small left axillary lymph node.*
- *Stationary [illegible] regarding rest of the study*

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Fawkeya Sayed Badr Rezk	Date : 01/04/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 59 Year(s)
Medical ID: 4320/2020	Pat. ID: 24357

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had left CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Left sided edema pattern and global asymmetry
- Scattered fibro glandular density (ACR B).
- No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Left breast operative bed focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness as well as seroma formation measuring 15 X 10 mm.
- Complementary ultrasound showed left breast operative bed focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no right breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with small seroma formation and free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Yours truly

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]